

Traumatismos frecuentes en la infancia

1. Introducción y relevancia clínica

Los **traumatismos en la infancia** constituyen la **principal causa de morbilidad y mortalidad infantil después del primer año de vida**, especialmente por accidentes domésticos, de tránsito o caídas.

La mayoría son **accidentales**, pero siempre se debe tener presente la posibilidad de **maltrato infantil** ante lesiones de características inusuales o incoherentes con el mecanismo relatado.

El manejo de un niño traumatizado exige una **evaluación sistemática y priorización de funciones vitales (ABC)**, además de conocer las particularidades anatómicas y fisiológicas pediátricas que modifican la respuesta al trauma.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a.

Características anatómicas del niño

- Cabeza proporcionalmente grande → mayor riesgo de **traumatismo craneal**.
- Caja torácica más elástica → lesiones pulmonares sin fracturas evidentes.
- Abdomen con órganos más expuestos → alto riesgo de lesión hepática o esplénica.
- Huesos más flexibles → **fracturas en tallo verde o rodete**.
- Reservas fisiológicas menores → **descompensación rápida** frente a hipovolemia.

□ En EUNACOM: “Niño con caída de altura + abdomen doloroso pero sin fractura de costillas → sospechar trauma abdominal cerrado.”

3. Clasificación y tipos de traumatismo

Tipo	Descripción	Ejemplos frecuentes
Cefálico (TEC)	Golpe en cráneo o cara	Caídas, accidentes de tránsito
Torácico	Contusión o compromiso respiratorio	Caídas, atropellos
Abdominal	Lesión de vísceras sólidas o huecas	Golpes directos, cinturón de seguridad
Músculo-esquelético	Fracturas, esguinces	Caídas, juegos, deportes
Cutáneo y quemaduras	Lesiones por contacto térmico, químico o fricción	Accidentes domésticos

4. Clínica y diagnóstico diferencial

A.

Traumatismo encéfalo craneano (TEC)

Clasificación (Escala de Glasgow pediátrica)

Grado	Glasgow w	Características
Leve	14–15	Sin pérdida de conciencia o <5 min
Moderado	9–13	Pérdida de conciencia >5 min, vómitos, cefalea

Grave	≤8	Coma, signos focales, respuesta motora anormal
-------	----	--

Signos de alarma:

- Vómitos repetidos.
- Somnolencia progresiva.
- Convulsiones.
- Pupilas asimétricas.
- Rinorrea u otorrea con líquido claro (fístula LCR).

Conducta:

- **TEC leve:** observación 6–12 h; alta si sin síntomas progresivos.
- **TEC moderado/grave:** TAC de cráneo urgente + hospitalización.
- Evitar sedantes o antieméticos hasta evaluación neurológica completa.

B.

Traumatismo torácico

Causas:

- Caídas de altura, accidentes de tránsito, compresión torácica.

Signos:

- Taquipnea, hipoxemia, movimientos paradójicos, enfisema subcutáneo.

Lesiones frecuentes:

- Contusión pulmonar.
- Neumotórax / hemotórax.

- Fractura costal (rara en menores de 3 años).

Conducta:

- Radiografía de tórax.
 - O₂ suplementario y drenaje pleural si neumotórax a tensión.
-

C.

Traumatismo abdominal

Mecanismo:

- Golpe directo o desaceleración.
- Causas comunes: caídas, bicicleta, cinturón de seguridad.

Signos:

- Dolor abdominal, distensión, palidez, hipotensión, equimosis en “cinturón”.

Sospechar lesión de órganos:

Órgano	Hallazgo clínico	Diagnóstico
Hígado	Dolor en hipocondrio derecho, shock	EcoFAST, TAC
Bazo	Dolor en hipocondrio izquierdo	TAC abdominal
Riñón	Hematuria	EAS, TAC

Conducta:

- Estabilización hemodinámica + Ecografía FAST.
- TAC abdominal contrastado si estable.

- Observación hospitalaria o cirugía si inestabilidad.

D.

Traumatismo músculo-esquelético

Fracturas típicas:

Tipo	Descripción
Tallo verde	Fisura incompleta del hueso largo.
Rodete	Abultamiento cortical, por compresión axial.
Epifisiaria (Salter-Harris)	Afecta la placa de crecimiento.

Manejo:

- Inmovilización con férula o yeso.
- Analgesia adecuada.
- Control radiográfico según evolución.

☐ En EUNACOM: "Fractura en tallo verde de radio sin desplazamiento → inmovilización simple, sin reducción."

E.

Traumatismos cutáneos y quemaduras

Clasificación de quemaduras:

Grado	Afectación	Características
-------	------------	-----------------

I (superficial)	Epidermis	Eritema, dolor, sin flictenas
-----------------	-----------	-------------------------------

II (intermedia)	Dermis parcial	Ampollas, dolor intenso
-----------------	----------------	-------------------------

III (profunda)	Dermis total	Piel seca, indolora
----------------	--------------	---------------------

Conducta:

- Lavar con suero fisiológico o agua corriente (no usar hielo).
- Analgesia y cobertura estéril.
- Referir a centro especializado si:
 - 10 % SCQ.
 - Cara, manos, genitales o articulaciones.
 - Sospecha de maltrato o quemadura eléctrica.

5. Sospecha de maltrato infantil

El **maltrato infantil** debe considerarse siempre ante lesiones inexplicables o incongruentes con el relato.

Ejemplos clásicos:

- Hematomas en distintas etapas evolutivas.
- Fracturas múltiples o en costillas posteriores.
- Lesiones perineales o quemaduras por inmersión.

☐ En Chile, **todo funcionario de salud está obligado por ley (Art. 175 del Código Penal)** a denunciar al Ministerio Público o Carabineros ante sospecha fundada.

6. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Tipo de trauma	Examen clave	Observaciones
Cefálico	TAC de cráneo	Solo si signos de alarma
Torácico	Rx tórax, gasometría	Evaluar contusión o neumotórax
Abdominal	Ecografía FAST / TAC contrastado	Identifica lesiones viscerales
Fracturas	Rx local	Proyecciones anteroposterior y lateral

Laboratorio: hemograma, gases, electrolitos, hematocrito, grupo y RH.

7. Tratamiento general y manejo inicial (ABCDE pediátrico)

1 ☐ A – Airway:

- Asegurar vía aérea; retirar cuerpos extraños; inmovilizar cuello.

2 ☐ B – Breathing:

- Oxígeno alto flujo.
- Drenaje pleural si neumotórax a tensión.

3 ☐ C – Circulation:

- Control de hemorragias.
- Canalizar 2 vías periféricas → suero fisiológico 20 mL/kg.

4 ☐ D – Disability:

- Evaluar Glasgow y pupilas.

5 ☐ E – Exposure:

- Exposición completa para búsqueda de lesiones ocultas.
- Prevenir hipotermia.

8. Complicaciones y pronóstico

Lesión	Complicaciones	Pronóstico
TEC grave	Edema cerebral, convulsiones	Variable
Trauma abdominal	Hemorragia interna	Buena si detectado precozmente
Fracturas múltiples	Lesión de crecimiento	Excelente en general
Quemaduras graves	Sepsis, cicatrices retráctiles	Depende del % SCQ
Maltrato infantil	Secuelas físicas y psicológicas	Requiere abordaje integral

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐

Perlas:

1. Todo niño traumatizado → evaluar **ABCDE pediátrico**.
2. **TEC leve sin signos de alarma**: observación, no TAC inmediato.
3. **Fractura en tallo verde**: no requiere reducción, solo inmovilización.
4. **Quemaduras faciales o perineales**: derivar a centro especializado.
5. **Trauma abdominal cerrado**: dolor + palidez + taquicardia = sospecha de hemoperitoneo.
6. **Maltrato infantil**: lesiones múltiples o incoherentes → denuncia obligatoria.
7. **Evitar sedantes o narcóticos** en TEC hasta evaluar Glasgow.



Errores frecuentes:

- No inmovilizar columna cervical en politrauma.
- Subestimar trauma abdominal sin fracturas costales.
- Enfriar con hielo directamente las quemaduras.
- Omitir denuncia ante sospecha de abuso.
- No reevaluar Glasgow seriado en TEC.

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Traumatismos infantiles** son causa principal de muerte prevenible.
2. Evaluación sistemática con **ABCDE pediátrico**.
3. **TEC leve**: observación 6–12 h; TAC solo si signos de alarma.
4. **Fracturas típicas pediátricas**: tallo verde y epifisiarias.
5. **Trauma abdominal cerrado**: sospechar lesión hepática/esplénica.
6. **Quemaduras >10 % o en zonas especiales** → derivar.

7. Siempre descartar **maltrato infantil** y cumplir **denuncia legal obligatoria**.